

Un bambino in età scolare nel vostro ambulatorio

Per medici di famiglia, infermieri e professionisti sanitari — nella cura di un bambino autistico alle scuole primarie (circa 6–11 anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un bambino si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi alla volta — vividi dentro, deboli fuori, e costosi da cambiare. La scuola è spesso la prima vera prova di stress: rumorosa, visivamente carica e imprevedibile, prosciuga l'attenzione che dovrebbe andare a tutto il resto. Molti bambini **si trattengono a scuola e crollano dopo** — anche nella vostra sala d'attesa. Lavorare con il tunnel, non contro di esso, è la chiave.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
„Va bene a scuola”, meltdown o shutdown a casa o in ambulatorio	Il bambino ha mascherato tutto il giorno; casa — e il vostro ambulatorio — è dove la maschera finalmente cade
Mal di pancia, mal di testa, „non vuole mangiare”; senza causa organica chiara	L'alto carico sensoriale e sociale si manifesta attraverso il corpo; anche comuni: co-occorrenza GI e del sonno
Difficoltà a iniziare, cambiare o fermarsi; sembra „pigro” o sfidante	Inerzia autistica — cambiare binario mentale costa energia reale, non forza di volontà
Abilità improvvisamente „perse” rispetto all'anno scorso	Spesso burnout / uno spostamento delle risorse attentive da sovraccarico, non vera regressione
Prende le cose alla lettera; ha bisogno di più tempo per rispondere	Comunicazione a canale singolo, letterale + tempo di elaborazione

Provate questo

- **Inviare un modulo pre-visita** (l'AHAT di AASPIRE, autismandhealth.org) e chiedete al genitore cosa aiuta; accogliete cuffie, occhiali da sole e un oggetto di conforto.
- **Prenotate lo slot più silenzioso**, abbassate le luci, riducete i bip; permettete un adulto di fiducia nella stanza.
- **Spiegate ogni passo prima di farlo**, in frasi brevi e letterali; lasciate che il bambino stimmi o tenga un oggetto di interesse.
- **Chiedete del carico scolastico e del recupero**, non solo dei sintomi — „Quanto ci mette a recuperare dopo una giornata di scuola?” segnala il sovraccarico.
- **Co-create una semplice routine sanitaria** (stessa stanza, stessa sequenza) per le visite ripetute.

Evitate questo

- Trattare la compostezza mascherata come „sta bene”, o uno shutdown come rifiuto di collaborare.
- Istruzioni verbali lunghe, procedure a sorpresa, o frasi „sii coraggioso!”.

- Spingere di più quando le abilità sono crollate — la risposta basata sulle evidenze al burnout è **ridurre le richieste e ripristinare riposo e interessi**.

Quando serve altro supporto

Guardatevi dal **burnout autistico** (esaurimento cronico, perdita di abilità, ridotta tolleranza agli stimoli) — è *distinto dalla depressione* e dallo stress ordinario, ed è peggiorato dal mascheramento. Screenate le co-occorrenze comuni: **ansia, ADHD (AuDHD), problemi del sonno e gastrointestinali**. Chiedete direttamente della frequenza scolastica e del bullismo. Segnalate il supporto del referente SEN/SEND e i gruppi di genitori guidati da persone autistiche.

Se il bambino è una bambina

Le bambine di questa età **camuffano molto** e sono spesso mancate o mal-diagnosticate (ansia, „timida“). Prendete sul serio l'osservazione dei genitori anche quando gli insegnanti vedono un bambino quieto e compiacente — il costo si paga fuori vista.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la sintesi sul **Monotropismo** e la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parti 3.2 e 4). Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela al singolo bambino.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2019, *Monotropism at School*; 2023); Dwyer (2025); Edgar (2024, *regressione/burnout*); Raymaker et al. (2020); AASPIRE AHAT; Kelly Mahler (2024). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.